

222 1184 1281

DN
522

THEREZINHA GOUVEA DA SILVA	
MEDICAMENTOS:	euthyrox / bromicar / kitmonorm / Neblock
SINTOMAS/QUEIXAS	nitroglicerina / QAS / samy / Bion 3 / Egit / fit
BANHEIRO	(2X) / boca seca / sódio / potássio / cefaleia
HORA QUE ACORDA	6:30 (faz sesta) HAS
HORA QUE DORME	23:30 IAH: 19.5 / lvr
PRATICA EXERCICIO	Não - oriento 3X 30'
HORARIO DAS REFEIÇÕES	
CAFE:	ALMOÇO: LANCHE: JANTA:
03/11/40	Acorda toma banho, faz café (tem ciúdeza)
02/11/40	TV assiste missa, borda, faz crochê. arruma a casa (mantem). Cochila no sofá, respira bem pelo nariz. Tem janela, no quarto, só com o corredor aberto, trocou o colchão recente, trocou o travesseiro. Prefere dormir lado esquerdo - fua
04/11/22	P = 10,5 cm H ₂ O IAH = 4,0 M. de uso: Ph 49' Fuga: 25,7 l/min Banheiro 1x à noite, acabou o cocô no sofá Bem adaptada redução PA e edema m. p. fua
28/11/22	P = 10,8 IAH = 2,3 eflv M. de uso: Ph 30' Fuga: 33,6 l/min 1x ao banheiro.
16/01/23	P = 10,8 IAH = 0,8 eflv M. de uso: Ph 42' fua Fuga: 24
27/02/2023	P = Auto 6 a 11 cm H ₂ O p min: 4 → igual 6 cm H ₂ O IAH = 0,7 média uso: 7h 50' fuga 10 l/min percentil 30 l/min
12/04/23	P = Auto - 6 - 10,5 cm H ₂ O IAH = 0,6 m. de uso: Ph 42' fua Bem adapt. Troco o filtro

19/06 pti relata bem adaptada, boca &
23 não está secando.

IAH = 1.0

M. de uso = 7h40'

P = 10.5

Bem adaptada.

usar 1 dia sim 1 dia não (esparadrapo) *lua.*

21/08/23 P = 10,3 cmH₂O P95%: 10,6 cmH₂O

IAH = 1,3 elh.

fuga = 17 l/min

m de uso: 7h50 min

→ não usou fita / nem gelatina

Auto 6-10,6

23/10/23 P = 8,6 cmH₂O P95%: 10,2

IAH = 0,9 elh

m. de uso = 7h30'

fuga = 44 l/min

↳ boca não seca / mas em fuga
= Bem adaptada

15/01
2024

P = 8,8 cmH₂O P95%: 10,3 cmH₂O

IAH = 1,1 elh

m de uso = 7horas

fuga = 40,7 l/min

Auto: 6 à 10,6 cmH₂O.

no sem boca seca;

Bem adaptada * troco filtro

08/11/24 P = 8,7 cmH₂O P95%: 10,2 cmH₂O

IAH = 1,3 elh

m. de uso: 7h26 min

fuga: 20,9 l/min

Bem adaptada
* troco filtro

Natasha

24/06/24 P = 6 - 10,6 cmH₂O / 10,4 cmH₂O (prontidão)

IAH = 2,2 elh

m de uso: 7h38m

fuga: 40 l/min

Bem adaptado

Natasha

26/08/24 P = 6 à 10,6 cmH₂O

IAH = 1,3 elh

m de uso: 7h40'

fuga: 33 l/min.

P mediana: 9,9 cmH₂O

P95%: 10,5 cmH₂O

Bem adaptada

* troco filtro *

Silvia

26/11/24 P = 9,3 cmH₂O

IAH = 0,8 elh

m de uso: 7h12'

fuga: 16 l/min

* troco filtro

Bem adaptada

Natasha

13/03/25 P = 8,8 g/L H₂O (mediana)

IAH = 0,7 e/h

mda ura: 7 h 41

fuogo: 37,5 l/m

Troco filtro
Bem adaptada

Natasha

17/06/25

P = 10 g/L H₂O (mediana)

IAH = 1,4 e/h

mda ura: 7 h 33

fuogo: 36 l/m

Troco filtro

Bem adaptada

Natasha

BÁUME MEDICINA RESPIRATÓRIA

LAUDO DE POLISSONOGRAFIA

Nome: Therezinha Gouvea da Silva

Data do exame: 19/09/22 Idade: 87 anos IMC: 23,8 kg/m²

Médico Solicitante: Dra Ana Claudia Contreira

Comentários:

Registro com início às 23 Hs e término às 06 Hs.

Paciente permaneceu 45% do tempo do exame em posição supina. Registro obtido com polissonógrafo portátil Embletta® (EMBLA) utilizando os seguintes canais: fluxo aéreo por cânula de pressão nasal, esforço respiratório torácico e abdominal, oximetria de pulso, actígrafo, eletrocardiograma, sensores de ronco e de posição.

Descrição dos resultados:

- Tempo total de registro: 394 minutos
- Índice de Distúrbio Respiratório (IDR): 19,5 eventos respiratórios/ hora de registro
- Registradas: 111 apnéias (111 obstrutiva, 0 mistas e 0 central) e 17 hipopnéias
- SpO₂ média durante o sono = 94 %; SpO₂ mínima 87%; SpO₂ Permaneceu 0,4% do tempo < 90%; OD 15,8/h
- Frequência cardíaca média de 64 bpm (variação de 58 a 81 bpm).

Conclusão

- Índice de apneia e hipopneia moderadamente aumentado (IAH 19,5) com predomínio de eventos obstrutivos respiratórios, associado à dessaturação da oxi-hemoglobina. Observou-se piora dos eventos obstrutivos na posição supina (IAH em posição supina 41,4).

- Presença de ronco;

- Ritmo cardíaco sinusal

- Os achados do presente estudo devem ser interpretados levando-se em conta a avaliação clínica e às limitações do método.

Dra. Mariah Prata S. P. Taube

Pneumologista

CRM 134230 / RQE 45087

Dra. Mariah Prata Soldi P. Taube

Pneumologia e Medicina do Sono